

COMA

L. J. Valdivia Ruiz, A.M. Fernández Martínez, J.P. Núñez Casco.

INTRODUCCIÓN

El **coma**, del griego “sueño o trance profundos”, es un estado de falta de respuesta en el que el paciente permanece con los ojos cerrados y no puede ser despertado para responder adecuadamente a estímulos, ni siquiera mediante una estimulación enérgica. El paciente puede gesticular como respuesta a estímulos dolorosos y las extremidades pueden presentar respuestas estereotipadas de retirada, pero no tiene respuestas de localización ni movimientos de defensa diferenciados. A medida que el coma se hace más profundo, las respuestas del paciente pueden disminuir o desaparecer incluso ante estímulos dolorosos.

El **estupor**, del latín “estar aturdido”; es un estado de sueño profundo o falta de respuesta conductual equivalente del que la persona sólo puede ser despertada mediante una estimulación enérgica y continua.

La **obnubilación**, del latín “golpear contra algo o embotar”, significa literalmente embotamiento o torpeza mentales. En un contexto médico, estos pacientes presentan una disminución leve o moderada de su estado de alerta, que se acompaña de un menor interés por el entorno.

DIAGNÓSTICO.

- **Anamnesis exhaustiva:** a familiares o acompañantes.
 - Forma de instauración del coma y síntomas acompañantes.
 - Hábitos tóxicos.
 - Antecedentes de epilepsia, hepatopatía crónica.
 - Medicación que toma el paciente.
- **Exploración física:**
 - General: constantes, lesiones cutáneas, zonas de venopunción.
 - Neurológica:
 - Nivel de conciencia: escala de Glasgow (GCS).
 - Patrón respiratorio.
 - Respuesta pupilar.
 - Reflejos óculo-cefálicos.
 - Asimetrías motoras o respuestas motoras patológicas (decorticación y descerebración).
 - Signos meníngeos.
- **Pruebas complementarias:**
 - Analítica: Hemograma, coagulación y bioquímica. Gasometría arterial. Tóxicos en orina.
 - Radiografía de tórax.
 - ECG.
 - TC craneal.
 - Punción lumbar, si procede.

MANEJO DEL PACIENTE EN COMA

Medidas Generales

- Asegurar la vía aérea: retirar cuerpos extraños y dentadura, aspirar secreciones, cánula de Guedel, valorar IOT (si GCS<9).

- Mantener una oxigenación adecuada: administrar O₂ para Sat.O₂>90%
- Mantener una perfusión adecuada: asegurar una TAM>70 mmHg.
- Toma de constantes, en cuanto sea posible: FC, TA, FR, Sat.O₂, T^a.
- Obtener vía venosa periférica: para obtención de muestra sanguínea y tratamientos.
- Glucemia: si hipoglucemia administrar Glucosmon y si normoglucemia iniciar sueroterapia con SSF 0,9%.
- Administrar Tiamina iv. (Benerva 100 mg)

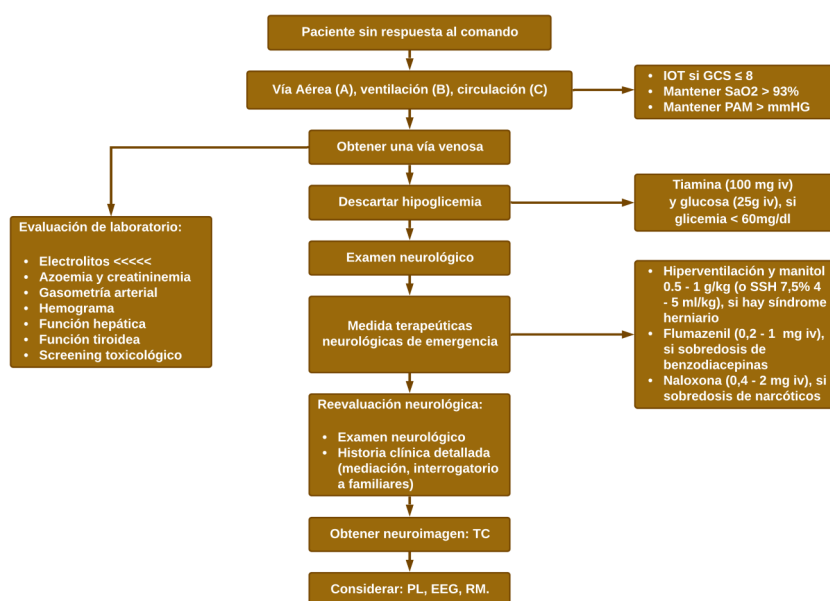
Medidas Específicas

- Sospecha intoxicación por opiáceos:
 - Naloxona 0,4-2mg iv. cada 3 minutos hasta máximo 10 mg.
 - Valorar perfusión: 0,2-0,5mg/h.
- Sospecha intoxicación por benzodiacepinas:
 - Flumazenilo (Anexate) 0,2 mg iv. cada minuto hasta máximo 3 mg.
 - Valorar perfusión (2,5mg en 500ml G5%): 0,1-0,4 mg/h.
- Sospecha de infección del SNC: iniciar tratamiento antibiótico lo antes posible, previa extracción de muestras microbiológicas para cultivo.
 - Bacteriana: Ceftriaxona 2g/12h + Vancomicina 15mg/kg/8-12h + Ampicilina 2g/4h iv.
 - Vírica: Aciclovir 10mg/kg/8h iv.
- Sospecha de estado proscritico tras crisis comicial: iniciar tratamiento anticomicial.

- DIFERENCIAR EL COMA METABÓLICO DEL ESTRUCTURAL. MANEJO INICIAL DEL PACIENTE SEGÚN PROTOCOLO ABC Y POSTERIORMENTE, SEGÚN ETIOLOGÍA.

Escala de coma de Glasgow

VARIABLE	RESPUESTA	PUNTUACIÓN
Apertura Ocular	Espontanea	4
	Estimulo verbal	3
	Al dolor	2
	Nula	1
Respuesta verbal	Orientado	5
	Desorientado	4
	Palabras inapropiadas	3
	Sonidos incomprensibles	2
	Nula	1
Respuesta motora	Obedece ordenes	6
	Localiza el dolor	5
	Retirada al dolor	4
	Reflejo flexor	3
	Reflejo extensor	2
	Nulo	1



BIBLIOGRAFÍA

- Plum and Posner's. Diagnosis of stupor and coma. Fourth edition.
- Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine. Seventh edition.